

ESCORE PELOD-2

Pediatric Logistic Organ Dysfunction 2 — Gravidade e Falência Orgânica em UTI Pediátrica

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome:		Idade:	
Prontuário:		Leito:	
Setor:		Data/Hora:	___/___/___ às __:__

2. PARÂMETROS DE DISFUNÇÃO ORGÂNICA EM UTI PEDIÁTRICA

Sistema Orgânico	Variável Clínica / Laboratorial	Pontuação por Faixa	Pts
1. Neurológico	• Escala de Glasgow • Reatividade Pupilar	☐ Glasgow 11-15 (0) • ☐ 5-10 (1) • ☐ 3-4 (4) ☐ Ambas reativas (0) • ☐ Ambas fixas (5)	☐ ☐
2. Cardiovascular	• Lactato sérico (mmol/L) • PAM hipotensa para idade	☐ Lactato < 5,0 (0) • ☐ 5,0-10,9 (1) • ☐ ≥ 11,0 (4) ☐ PAM normal p/ idade (0) • ☐ Hipotensão grave (2)	☐ ☐
3. Renal	• Creatinina sérica (μmol/L ou mg/dL)	☐ Normal para idade (0) • ☐ Levemente elevada (1) • ☐ >2x limite superior normal (2)	☐ ☐
4. Respiratório	• PaO ₂ /FiO ₂ ou PaCO ₂ • Ventilação Mecânica Invasiva	☐ PaO ₂ /FiO ₂ ≥ 400 (0) • ☐ 200-399 (1) • ☐ < 200 (2) ☐ Sem ventilação mecânica (0) • ☐ Em VMI (1)	☐ ☐
5. Hematológico	• Contagem de Plaquetas • Leucócitos totais	☐ Plaquetas ≥ 70 x10 ³ /mm ³ (0) • ☐ 35-69 (1) • ☐ < 35 (2) ☐ Leucócitos ≥ 2,0 x10 ³ /mm ³ (0) • ☐ < 2,0 (2)	☐ ☐

ESCORE TOTAL PELOD-2 (0 a 33): PONTOS

3. ESTRATIFICAÇÃO PROGNÓSTICA E RISCO DE MORTALIDADE NA UTIP

0 a 5 PONTOS	6 a 12 PONTOS	≥ 13 PONTOS
Baixo Risco (< 2% mortalidade): Disfunção orgânica mínima; evolução estável em terapia intensiva.	Risco Moderado a Alto (10% a 35%): Disfunção de múltiplos órgãos; suporte intensivo e monitorização contínua.	Gravidade Extrema (> 50% de mortalidade): Falência de múltiplos órgãos; suporte avançado de vida invasivo.

Carimbo e Assinatura do Profissional Responsável

Local e Data